NAJDETE HO A VÍTE, CO DĚLAT™

60 protokolů ošetření podle svalů

Atlas vám ukáže, kde bod je. Tento průvodce vám řekne, co s ním dělat: poloha, technika, protažení, dávkování a domácí úkol, sval po svalu.

Atlas spoušťových bodů · Vzdělávací materiál pro zdravotnické odborníky a studenty. Nenahrazuje lékařskou diagnózu.

Obsah

1 · Obecné zásady

2 · Hlava, obličej a krk

3 · Rameno, paže a ruka

4 · Záda a trup

5 · Pánev a kyčel

6 · Stehno, bérec a chodidlo

Další krok

ČÁST 1

Obecné zásady

Každý protokol sleduje tento postup.

Pro koho je určen

Vzdělávací materiál pro fyzioterapeuty, maséry, osteopaty, trenéry a studenty zdravotnických oborů. Protokoly shrnují běžně používané manuální techniky ošetření myofasciálních spoušťových bodů. Nenahrazují lékařskou diagnózu a nenahrazují váš vlastní odborný úsudek.

KROK	CO DĚLÁTE	JAK DLOUHO
1. Vyhledání	Najděte napjatý pruh a v něm nejcitlivější bod (podle karty v atlasu).	—
2. Ischemická komprese	Postupný, trvalý tlak na bod, dokud pacient na škále 0–10 neudává nepříjemnost asi 5–7. Když napětí povolí, následujte ho hlouběji.	30–90 s, 3–5 opakování
3. Protažení	Pomalé, bezbolestné protažení ošetřeného svalu při výdechu.	3 × 20–30 s
4. Aktivní pohyb	Pacient několikrát provede sval celým rozsahem pohybu.	3–5 opakování
5. Domů	Dejte jednoduché protažení nebo úkol (viz konec protokolu).	1–2× denně

Kdy NEOŠETŘOVAT (a poslat k lékaři)

Čerstvé poranění nebo otok, horečka, noční bolest neznámého původu, necitlivost nebo slabost, která neodpovídá vzorci přenesené bolesti, podezření na trombózu, kožní onemocnění v dané oblasti. U pacienta užívajícího antikoagulancia používejte jen mírný tlak.

ČÁST 2

Hlava, obličej a krk

12 svalů, v pořadí atlasu.

1. Trapezius – horní vlákna

Musculus trapezius, pars descendens

KDE HLEDAT	Nahoře na ramenním pletenci, v polovině vzdálenosti mezi krkem a akromionem, na horním volném okraji.
PŘENESENÁ BOLEST	spánek, strana hlavy, strana krku, za uchem, úhel dolní čelisti
PACIENT	Vleže na zádech nebo vsedě, paže volně v klíně.
TECHNIKA	• Klešťový úchop horních vláken (palec a ukazovák), ischemická komprese držená na napjatém pruhu. • Alternativa: plošný tlak bříšky prstů nahoře na ramenním pletenci.
PROTAŽENÍ	Hlava ukloněná na opačnou stranu s mírnou flexí; vsedě se pacient drží rukou na stejné straně za spodek židle.
DÁVKOVÁNÍ	3–5 × 30–90 s komprese, poté 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Protažení do úklonu dvakrát denně; monitor ve výši očí; nedržet telefon mezi uchem a ramenem.

2. Sternocleidomastoideus (SCM)

Musculus sternocleidomastoideus

KDE HLEDAT	Podél bříška svalu, zvlášť na sternální a klavikulární části; nejcitlivější ve střední třetině.
PŘENESENÁ BOLEST	čelo, okolí oka, tvář, hluboko v uchu, temeno, týl
PACIENT	Vleže na zádech, hlava mírně ukloněná k ošetřované straně, aby se sval uvolnil.
TECHNIKA	• Pouze klešťový úchop: uchopte bříško svalu dvěma prsty a nadzvedněte ho od hlubokých struktur krku. • Sternální a klavikulární část ošetřujte každou zvlášť, postupujte zdola nahoru.
PROTAŽENÍ	Hlava ukloněná na opačnou stranu, poté se brada pomalu otáčí k ošetřované straně; mírný záklon jen tehdy, pokud nevyvolává závrať.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s klešťové komprese na každou část, poté 2–3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Pomalé kývání a otáčení hlavou; vyhýbat se sledování televize vleže a čtení s podloženou hlavou.

Opatrně: Arteria carotis probíhá přímo pod svalem: nikdy netlačte dozadu na přední straně krku. Při závrati, nevolnosti nebo poruše vidění okamžitě přestaňte.

3. Masseter (žvýkací sval)

Musculus masseter

KDE HLEDAT	V povrchové vrstvě pod jařmovým obloukem a nad úhlem dolní čelisti; v hluboké vrstvě před čelistním kloubem.
PŘENESENÁ BOLEST	horní a dolní stoličky, dolní čelist, obočí, hluboko v uchu
PACIENT	Vleže na zádech, ústa mírně otevřená.
TECHNIKA	• Zvenku: plošná komprese bříšky prstů pod jařmovým obloukem a nad úhlem čelisti. • Zevnitř (v rukavici): klešťový úchop, jeden prst v ústech, druhý venku; pomalé tření napříč vlákny.
PROTAŽENÍ	Pomalé otevírání úst se špičkou jazyka na patře; dva prsty terapeuta jemně pomáhají čelisti dolů.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s komprese, 2–3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Denní automasáž krouživými pohyby; vyhýbat se žvýkačkám; sledovat denní zatínání zubů.

> **Opatrně:** U čerstvé bolesti čelistního kloubu nebo zubních potíží nejprve vyšetření u zubního lékaře. V ústech vždy používejte rukavici.

4. Temporalis (spánkový sval)

Musculus temporalis

KDE HLEDAT	Ve čtyřech oblastech nad jařmovým obloukem, zepředu dozadu; při žvýkání dobře hmatný.
PŘENESENÁ BOLEST	spánek, obočí, za okem, horní zuby, strana hlavy
PACIENT	Vleže na zádech nebo vsedě, zuby mírně od sebe.
TECHNIKA	• Plošná komprese bříšky prstů na čtyřech skupinách vláken nad jařmovým obloukem, zepředu dozadu. • Na napjatých pruzích pomalé tření napříč vlákny.
PROTAŽENÍ	Pomalé otevírání úst, zatímco prsty terapeuta hladí na spánku směrem nahoru.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s na každý bod, poté 3–5 pomalých tahů.
DOMŮ	Automasáž spánků na začátku bolesti hlavy; sledovat noční skřípání zuby.

5. Pterygoideus lateralis

Musculus pterygoideus lateralis

KDE HLEDAT	Hluboko pod jařmovým obloukem; intraorálně za horními stoličkami, směrem nahoru a dozadu.
PŘENESENÁ BOLEST	čelistní kloub, tvář (nad čelistní dutinou)
PACIENT	Vleže na zádech, ústa napůl otevřená.
TECHNIKA	• Intraorálně, v rukavici: opatrný, pomalý tlak malíčkem za horními stoličkami. • Zvenku: komprese v prohlubni pod jařmovým obloukem při otevřených ústech.
PROTAŽENÍ	Pomalá retrakce dolní čelisti (pacient mírně stáhne bradu dozadu), poté pomalé zavření úst.
DÁVKOVÁNÍ	2–3 × 20–30 s šetrného tlaku, 2 × 20 s protažení.
DOMŮ	Vyhýbat se tvrdým a velkým soustům; vědomě pomalu otevírat ústa v přímé linii.

Opatrně: Intraorálně jen v rukavici a velmi jemně; při bolestivém lupání nebo zasekávání čelisti zubní lékař nebo stomatochirurg.

6. Pterygoideus medialis

Musculus pterygoideus medialis

KDE HLEDAT	Na vnitřní straně úhlu dolní čelisti, palpace zespodu; intraorálně za poslední stoličkou.
PŘENESENÁ BOLEST	kořen jazyka, hrdlo, pod uchem, čelistní kloub
PACIENT	Vleže na zádech, hlava mírně otočená k ošetřované straně.
TECHNIKA	• Zvenku: tlak bříšky prstů na vnitřní plochu úhlu čelisti, směrem nahoru. • Intraorálně (v rukavici): opatrný tlak za poslední stoličkou směrem k patru.
PROTAŽENÍ	Pomalé otevírání úst s čelistí mírně posunutou na opačnou stranu.
DÁVKOVÁNÍ	2–3 × 20–30 s komprese, 2 × 20 s protažení.
DOMŮ	Vědomě povolovat zaťaté zuby; ve dnech s bolestí měkká strava.

Opatrně: Při bolesti při polykání nebo potížích v krku nejprve lékařské vyšetření.

7. Splenius capitis

Musculus splenius capitis

KDE HLEDAT	V zadní boční části krku, mezi SCM a trapeziem, asi 2–3 prsty pod týlem.
PŘENESENÁ BOLEST	temeno
PACIENT	Vleže na zádech nebo na břiše, hlava ve středním postavení.
TECHNIKA	• Plošná komprese bříšky prstů v trojúhelníku mezi SCM a trapeziem, směrem nahoru a dovnitř. • Podélné tahy směrem k týlu.
PROTAŽENÍ	Hlava v předklonu a otočená na opačnou stranu.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s komprese, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Vyhýbat se dlouhému dívání nahoru (malování, skládání do polic); vhodná výška polštáře.

8. Splenius cervicis

Musculus splenius cervicis

KDE HLEDAT	V dolní části krku, nad horním úhlem lopatky, vedle levator scapulae.
PŘENESENÁ BOLEST	za okem, týl, přechod krku a ramene
PACIENT	Vleže na břiše, čelo podložené.
TECHNIKA	• Komprese bříšky prstů u kořene krku, laterálně vedle páteře. • Pomalé tření napříč na napjatém pruhu.
PROTAŽENÍ	Hlava v předklonu a v úklonu s rotací na opačnou stranu.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, poté 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Korekce předsunutého držení hlavy; každou hodinu pohybová přestávka.

9. Subokcipitální svaly

Mm. recti capitis posteriores et obliqui capitis

KDE HLEDAT	Přímo pod kostí týlní, po obou stranách střední čáry, v hloubce.
PŘENESENÁ BOLEST	strana hlavy, za okem, čelo, týl
PACIENT	Vleže na zádech, terapeut sedí u hlavy.
TECHNIKA	• Bříška prstů terapeuta pod kostí týlní, tlak vytváří váha hlavy (subokcipitální uvolnění). • Počkejte, až tkáň povolí a prsty pomalu klesnou hlouběji.
PROTAŽENÍ	Zasunutí brady (hlava klouže rovně dozadu), poté mírné kývnutí dopředu.
DÁVKOVÁNÍ	1–2 × 60–120 s uvolnění, poté 5–10 pomalých zasunutí brady.
DOMŮ	Zasunutí brady 10× denně; obrazovka ve výši očí; každou hodinu krátká přestávka.

> **Opatrně:** Při závrati, poruše vidění, necitlivosti nebo obtížném polykání okamžitě přestaňte a pošlete pacienta k lékaři.

10. Semispinalis capitis

Musculus semispinalis capitis

KDE HLEDAT	Na zátylku, 2–3 cm od střední čáry, pod týlem a uprostřed krku.
PŘENESENÁ BOLEST	strana hlavy, spánek, čelo, týl
PACIENT	Vleže na břiše, nebo na zádech s hlavou otočenou na stranu.
TECHNIKA	• Komprese bříšky prstů vedle páteře, postupně zdola nahoru. • Podélné tahy směrem k týlu.
PROTAŽENÍ	Hlava v předklonu s mírnou rotací do strany.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, poté 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Vyhýbat se předsunutému držení hlavy; při čtení knihu ve výši očí.

11. Levator scapulae (zdvihač lopatky)

Musculus levator scapulae

KDE HLEDAT	Mírně mediálně nad horním úhlem lopatky a na straně krku v hloubce pod horním okrajem trapezia.
PŘENESENÁ BOLEST	přechod krku a ramene, vnitřní okraj lopatky, zadní část ramene
PACIENT	Vleže na břiše nebo vsedě, paže volně.
TECHNIKA	• Komprese nad horním úhlem lopatky, mírně mediálně. • Druhý bod: na straně krku, v hloubce pod horním okrajem trapezia.
PROTAŽENÍ	Hlava v předklonu a otočená na opačnou stranu (nosem k podpaží), ruka ošetřované strany za zátylkem.
DÁVKOVÁNÍ	3–5 × 30–90 s komprese, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Totéž protažení dvakrát denně; vyhýbat se vysokému polštáři a otáčení hlavy do strany při práci.

12. Skalenové svaly

Mm. scaleni anterior, medius et posterior

KDE HLEDAT	Na straně krku, za SCM a pod ním, nad klíční kostí.
PŘENESENÁ BOLEST	přední strana hrudníku, paže, vnitřní okraj lopatky, ruka (palec a ukazovák)
PACIENT	Vleže na zádech, hlava mírně ukloněná k ošetřované straně.
TECHNIKA	• Plošný, velmi jemný tlak břišky prstů za zadním okrajem SCM, nad klíční kostí. • Krátké výdrže 20–30 s; pacient dýchá zhluboka do břicha.
PROTAŽENÍ	Hlava ukloněná na opačnou stranu s mírným záklonem; terapeut fixuje klíční kost ošetřované strany směrem dolů.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 20–30 s šetrného tlaku, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Nácvik břišního (bráničního) dýchání; nenosit těžkou tašku na rameni.

> **Opatrně:** V této oblasti probíhá plexus brachialis a cévy: pokud se do paže šíří necitlivost nebo mravenčení, snižte tlak nebo přestaňte. Při trvalé necitlivosti lékařské vyšetření.

ČÁST 3

Rameno, paže a ruka

14 svalů, v pořadí atlasu.

13. Infraspinatus

Musculus infraspinatus

KDE HLEDAT	Na zadní ploše lopatky, pod hřebenem lopatky, ve střední a horní části fossa infraspinata.
PŘENESENÁ BOLEST	přední část ramene (hluboko), přední zevní strana paže, předloktí, palcová strana ruky
PACIENT	Vleže na břiše, nebo vleže na boku s ošetřovanou stranou nahoře.
TECHNIKA	• Plošná komprese bříšky prstů nebo palcem na zadní ploše lopatky. • Postupujte bod po bodu od hřebene lopatky směrem dolů.
PROTAŽENÍ	Paže ošetřované strany zkřížená přes hrudník, druhou rukou přitahujte loket k hrudníku; nebo ruka za zády.
DÁVKOVÁNÍ	3–5 × 30–90 s, poté 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Nespat na bolestivé straně; vleže na boku podložit paži polštářem.

14. Supraspinatus

Musculus supraspinatus

KDE HLEDAT	Nad hřebenem lopatky, v mediální části fossa supraspinata a laterálně pod akromionem.
PŘENESENÁ BOLEST	strana ramene (oblast deltoideu), zevní strana paže, zevní strana lokte
PACIENT	Vsedě nebo vleže na břiše.
TECHNIKA	• Hluboká komprese bříšky prstů nad hřebenem lopatky, přes vlákna trapezia. • Laterálně v blízkosti šlachy jen jemný tlak.
PROTAŽENÍ	Ruka ošetřované strany za zády, druhá ruka jemně táhne zápěstí na opačnou stranu.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Vyhýbat se zvedání těžkých předmětů nad hlavu; denně kroužení rameny.

Opatrně: Akutní ostrá bolest ramene nebo noční bolest, která nepolevuje: lékařské vyšetření k vyloučení poranění rotátorové manžety.

15. Teres minor

Musculus teres minor

KDE HLEDAT	Na zevním okraji lopatky, pod infraspinatem, nad zadní podpažní řasou.
PŘENESENÁ BOLEST	zadní část ramene (bodově), zadní strana paže
PACIENT	Vleže na břiše s paží svěšenou z okraje lehátka, nebo vleže na boku.
TECHNIKA	• Klešťový úchop nebo komprese palcem na zevním okraji lopatky, nad zadní podpažní řasou.
PROTAŽENÍ	Paže zkřížená přes hrudník, loket přitažený k hrudníku.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Stejně jako u infraspinatu; nespat s paží nad hlavou.

16. Subscapularis

Musculus subscapularis

KDE HLEDAT	Na přední ploše lopatky, dosažitelný z podpaží, podél zevního okraje lopatky.
PŘENESENÁ BOLEST	zadní část ramene, lopatka, zadní strana paže, zápěstí
PACIENT	Vleže na zádech, paže v abdukci asi 45° a v zevní rotaci.
TECHNIKA	• Přes podpaží bříšky prstů směrem k přední ploše lopatky, velmi pomalu. • Krátké výdrže podle signálu pacienta.
PROTAŽENÍ	Paže v zevní rotaci, loket v 90°, ruku jemně nechat jít dozadu (u zárubně dveří).
DÁVKOVÁNÍ	2–3 × 20–30 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Nácvik zevní rotace; paže nemá zůstávat dlouho přitisknutá k tělu.

> **Opatrně:** V podpaží probíhají cévy a nervy: postupujte pomalu a jemně; při necitlivosti povolte.

17. Deltoideus

Musculus deltoideus

KDE HLEDAT	V předních, středních a zadních vláknech, 2–5 cm pod akromionem.
PŘENESENÁ BOLEST	rameno (kolem bodu), paže
PACIENT	Vsedě nebo vleže na zádech.
TECHNIKA	• Plošná nebo klešťová komprese na každé ze tří skupin vláken zvlášť. • Tření napříč na napjatých pruzích.
PROTAŽENÍ	Přední vlákna: paže dozadu; zadní vlákna: paže zkřížená přes hrudník.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s na každou skupinu vláken, 2–3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Přestávky při opakovaném zvedání.

18. Pectoralis major

Musculus pectoralis major

KDE HLEDAT	Na zevním okraji prsního svalu (přední podpažní řasa), pod klíční kostí a vedle hrudní kosti.
PŘENESENÁ BOLEST	přední část hrudníku, přední část ramene, vnitřní strana paže, prsa
PACIENT	Vleže na zádech, paže mírně v abdukci.
TECHNIKA	• Klešťový úchop přední podpažní řasy. • Plošná komprese pod klíční kostí a vedle hrudní kosti.
PROTAŽENÍ	Protažení ve dveřích: předloktí na zárubni, loket ve výši ramene, tělo pomalu vykročí dopředu.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–90 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Korekce shrbeného držení; ramena dozadu a dolů.

> **Opatrně:** Při bolesti na levé straně hrudníku, zvlášť při námaze, s dušností nebo pocením: nejprve vyloučit srdeční příčinu, urgentně k lékaři.

19. Pectoralis minor

Musculus pectoralis minor

KDE HLEDAT	Pod processus coracoideus, nad 3.–5. žebrem, hluboko pod pectoralis major.
PŘENESENÁ BOLEST	přední část ramene, hrudník, vnitřní strana paže, malíková strana ruky
PACIENT	Vleže na zádech, paže podél těla.
TECHNIKA	• Plošný tlak bříšky prstů pod pectoralis major, z podpaží dovnitř a nahoru. • Krátké výdrže s pomalým dýcháním.
PROTAŽENÍ	Ramena dozadu a dolů; u zárubně loket nad výší ramene.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 20–30 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Korekce předsunutého ramene; posilování zádových svalů.

> **Opatrně:** Pokud se do paže šíří necitlivost, snižte tlak.

20. Rhomboideus

Mm. rhomboidei major et minor

KDE HLEDAT	Mezi vnitřním okrajem lopatky a páteří, pod trapeziem.
PŘENESENÁ BOLEST	vnitřní okraj lopatky, mezi lopatkami
PACIENT	Vleže na břiše, paže volně podél lehátka.
TECHNIKA	• Komprese palcem podél vnitřního okraje lopatky, shora dolů. • Tření napříč vlákny.
PROTAŽENÍ	Paže zkřížené vpředu (objetí sebe sama), záda mírně vyhrbená.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Protahování prsního svalu (rhomboideus bývá často přetažený a slabý).

21. Serratus anterior

Musculus serratus anterior

KDE HLEDAT	Na straně hrudníku, pod podpažím ve výši 5.–6. žebra.
PŘENESENÁ BOLEST	boční strana hrudníku, dolní úhel lopatky, vnitřní strana paže
PACIENT	Vleže na boku, ošetřovaná strana nahoře, paže vpředu.
TECHNIKA	• Plošný tlak bříšky prstů mezi žebry, pod podpažím. • Pomalé tahy podél žeber.
PROTAŽENÍ	Paže dozadu a lopatka přitažená k páteři; při hlubokém nádechu.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 20–30 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Častý po kašli a intenzivním běhu: postupná zátěž.

Opatrně: Při ostré boční bolesti související s dýcháním, horečce nebo kašli nejprve lékařské vyšetření.

22. Latissimus dorsi

Musculus latissimus dorsi

KDE HLEDAT	V zadní podpažní řase, ve výši dolního úhlu lopatky.
PŘENESENÁ BOLEST	dolní úhel lopatky, zadní vnitřní strana paže, prsteník a malíček
PACIENT	Vleže na břiše nebo na boku, paže zvednutá nad hlavu.
TECHNIKA	• Klešťový úchop zadní podpažní řasy. • Plošná komprese vedle dolního úhlu lopatky.
PROTAŽENÍ	Paže nad hlavou, trup v úklonu na opačnou stranu.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Protažení po shybech a tažných pohybech.

23. Biceps brachii

Musculus biceps brachii

KDE HLEDAT	Ve střední třetině přední strany paže, v obou hlavách.
PŘENESENÁ BOLEST	přední část ramene, loketní jamka
PACIENT	Vleže na zádech, loket mírně pokrčený.
TECHNIKA	• Klešťový úchop na bříšku svalu. • Plošná komprese ve střední třetině.
PROTAŽENÍ	Loket natažený, předloktí v pronaci, paže dozadu.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Vyhýbat se nošení těžkých předmětů s pokrčeným loktem.

24. Triceps brachii

Musculus triceps brachii

KDE HLEDAT	Na zadní straně paže, v dlouhé hlavě pod podpažím a 4–6 cm nad loktem.
PŘENESENÁ BOLEST	zadní část ramene, zevní strana lokte, zadní strana předloktí
PACIENT	Vleže na břiše s paží svěšenou, nebo na zádech s paží nad hlavou.
TECHNIKA	• Klešťový úchop na dlouhé hlavě. • Plošná komprese nad loktem.
PROTAŽENÍ	Paže nad hlavou, loket plně pokrčený, druhá ruka ho jemně tlačí dozadu.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Přestávky při chůzi o berlích a při klicích.

25. Extenzory předloktí (ECRL, ECRB, extensor digitorum)

Mm. extensores carpi radiales et extensor digitorum

KDE HLEDAT	Na zadní zevní straně předloktí, 3–6 cm pod loktem.
PŘENESENÁ BOLEST	zevní strana lokte, zadní strana předloktí, hřbet ruky, prsty
PACIENT	Vsedě, předloktí na stole, dlaní dolů.
TECHNIKA	• Komprese palcem na bříškách svalů pod loktem. • Tření napříč na bříšku svalu (ne na kostěném úponu).
PROTAŽENÍ	Loket natažený, zápěstí a prsty ve flexi, druhá ruka jemně táhne dolů.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Přestávky při práci s myší a šroubování; povolit stisk.

> **Opatrně:** Při otoku, teplotě nebo noční necitlivosti nejprve lékařské vyšetření.

26. Flexory předloktí

Mm. flexores carpi et digitorum

KDE HLEDAT	Na vnitřní přední straně předloktí, 3–6 cm pod loktem.
PŘENESENÁ BOLEST	dlaňová strana zápěstí, dlaň, dlaňová strana prstů
PACIENT	Vsedě, předloktí na stole, dlaní nahoru.
TECHNIKA	• Komprese palcem na bříškách svalů. • Podélné tahy směrem k zápěstí.
PROTAŽENÍ	Loket natažený, dlaň nahoru, prsty tažené dozadu.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Přestávky při manuální práci (zahrada, montáž); povolit úchop.

Opatrně: Při noční necitlivosti šířící se do prstů (např. karpální tunel) lékařské vyšetření.

ČÁST 4

Záda a trup

10 svalů, v pořadí atlasu.

27. Trapezius – střední vlákna

Musculus trapezius, pars transversa

KDE HLEDAT	Mezi vnitřním okrajem lopatky a páteří, ve výši hřebene lopatky, povrchově.
PŘENESENÁ BOLEST	mezi lopatkami, pálení vedle páteře
PACIENT	Vleže na břiše, paže podél lehátka.
TECHNIKA	• Plošná komprese palcem vedle vnitřního okraje lopatky. • Tření napříč vlákny.
PROTAŽENÍ	Paže zkřížené vpředu, záda vyhrbená.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Korekce shrbeného sedu; protahování prsního svalu.

28. Trapezius – dolní vlákna

Musculus trapezius, pars ascendens

KDE HLEDAT	Mezi dolním úhlem lopatky a páteří, ve střední části zad.
PŘENESENÁ BOLEST	zadní strana krku, akromion, mezi lopatkami
PACIENT	Vleže na břiše.
TECHNIKA	• Klešťový úchop nebo komprese palcem vedle dolního úhlu lopatky, mediálně.
PROTAŽENÍ	Paže dopředu a nahoru, záda vyhrbená.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Posilování: vleže na břiše zvedání paží do tvaru Y.

29. Serratus posterior superior

Musculus serratus posterior superior

KDE HLEDAT	Pod horní částí lopatky, vedle páteře; dosažitelný po odtažení lopatky do strany.
PŘENESENÁ BOLEST	hluboko pod lopatkou, zadní část ramene, zadní strana paže, malíček
PACIENT	Vsedě, paže ošetřované strany zkřížená před tělem, aby se lopatka odtáhla.
TECHNIKA	• Plošná komprese bříšky prstů pod horním vnitřním okrajem lopatky, na žebru. • Krátké výdrže s pomalým dýcháním.
PROTAŽENÍ	Paže zkřížená vpředu, záda vyhrbená.
DÁVKOVÁNÍ	2–3 × 20–30 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Místo horního hrudního (překotného) dýchání břišní dýchání.

30. Iliocostalis thoracis

Musculus iliocostalis thoracis

KDE HLEDAT	Asi 5–8 cm od páteře, ve střední a dolní hrudní oblasti.
PŘENESENÁ BOLEST	střed zad, břicho (někdy), pod lopatkou
PACIENT	Vleže na břiše, pod břichem malý polštář.
TECHNIKA	• Komprese palcem na zevním okraji vzpřimovače páteře. • Podélné tahy směrem dolů.
PROTAŽENÍ	Vsedě předklon, trup mírně otočený na opačnou stranu.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Pohybové přestávky při dlouhém sezení.

Opatrně: U bolesti zad s bolestí břicha, horečkou nebo potížemi s močením nejprve lékařské vyšetření.

31. Iliocostalis lumborum

Musculus iliocostalis lumborum

KDE HLEDAT	V bederní oblasti asi 5–7 cm od páteře, pod dolními žebry.
PŘENESENÁ BOLEST	kříž, hýždě, dolní část břicha
PACIENT	Vleže na břiše, pod břichem polštář.
TECHNIKA	• Komprese palcem nebo loktem na zevním okraji vzpřimovače páteře.
PROTAŽENÍ	Vleže na zádech kolena přitažená k hrudníku.
DÁVKOVÁNÍ	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Zvedat z kolen s rovnými zády; přerušovat dlouhé sezení.

Opatrně: Necitlivost nebo slabost šířící se do nohy, porucha močení nebo vyprazdňování: okamžitě k lékaři.

32. Longissimus thoracis

Musculus longissimus thoracis

KDE HLEDAT	2–4 cm od páteře, v dolní hrudní a horní bederní oblasti.
PŘENESENÁ BOLEST	hýždě, kříž, hřeben kosti kyčelní
PACIENT	Vleže na břiše.
TECHNIKA	• Komprese palcem vedle páteře, zdola nahoru.
PROTAŽENÍ	Vsedě předklon, nebo vleže na zádech kolena k hrudníku.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Každou hodinu přerušit sedavou práci.

Opatrně: Při necitlivosti nebo slabosti šířící se do nohy lékařské vyšetření.

33. Multifidus

Musculus multifidus

KDE HLEDAT	Těsně vedle trnových výběžků, v hloubce, v kterékoli oblasti páteře (nejčastěji bederní).
PŘENESENÁ BOLEST	bodově vedle páteře, kost křížová, břicho (vzácně)
PACIENT	Vleže na břiše, pod břichem polštář.
TECHNIKA	• Hluboká, pomalá komprese palcem vedle trnového výběžku, šikmo dovnitř.
PROTAŽENÍ	Vleže na zádech kolena k hrudníku s mírnou rotací do strany.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Aktivace hlubokého stabilizačního systému (vtažení břicha bez zatnutí břišního lisu).

34. Quadratus lumborum

Musculus quadratus lumborum

KDE HLEDAT	Mezi posledním žebrem a hřebenem kosti kyčelní, na zevním okraji vzpřimovače páteře, v hloubce.
PŘENESENÁ BOLEST	hřeben kosti kyčelní, hýždě, strana kyčle, kříž
PACIENT	Vleže na boku, ošetřovaná strana nahoře, horní noha spuštěná dozadu (vzdálenost kyčel–žebro se zvětší).
TECHNIKA	• Komprese palcem na okraji vzpřimovače páteře, dovnitř směrem k páteři. • Dva body: pod posledním žebrem a nad kostí kyčelní.
PROTAŽENÍ	Ve stoje nebo vleže na boku úklon, horní paže nad hlavou.
DÁVKOVÁNÍ	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Vyhýbat se stání na jedné noze a nošení tašky na jedné straně.

Opatrně: Bolest v oblasti ledvin s horečkou nebo potížemi s močením: nejprve lékařské vyšetření.

35. Rectus abdominis

Musculus rectus abdominis

KDE HLEDAT	Nad pupkem a pod ním, 2–4 cm od střední čáry.
PŘENESENÁ BOLEST	vodorovný pruh přes střed zad, břicho, kříž
PACIENT	Vleže na zádech, pod koleny polštář.
TECHNIKA	• Klešťový úchop nebo plošná komprese na okraji svalu.
PROTAŽENÍ	Vleže na zádech, polštář pod bedry, paže nad hlavou.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 20–30 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Protažení po přehnaném posilování břišních svalů.

> **Opatrně:** Bolest břicha s horečkou, zvracením, změnou stolice nebo moči: lékařské vyšetření, neošetřovat.

36. Obliquus externus abdominis

Musculus obliquus externus abdominis

KDE HLEDAT	Na straně břicha, pod žeberním obloukem a nad hřebenem kosti kyčelní.
PŘENESENÁ BOLEST	strana břicha, kříž, dolní část hrudníku
PACIENT	Vleže na zádech nebo na boku.
TECHNIKA	• Plošná komprese bříšky prstů pod žeberním obloukem. • Klešťový úchop na straně břicha.
PROTAŽENÍ	Vleže na zádech kolena spuštěná na opačnou stranu, ramena na podložce.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 20–30 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Postupná zátěž při rotačních pohybech.

> **Opatrně:** U břišních potíží nejprve vyloučit interní příčiny.

ČÁST 5

Pánev a kyčel

10 svalů, v pořadí atlasu.

37. Gluteus maximus

Musculus gluteus maximus

KDE HLEDAT	V dolní vnitřní části hýždě, vedle kosti křížové a nad sedacím hrbolem.
PŘENESENÁ BOLEST	hýždě, kost křížová, okolí kostrče
PACIENT	Vleže na břiše nebo na boku.
TECHNIKA	• Komprese loktem nebo palcem vedle kosti křížové a nad sedacím hrbolem.
PROTAŽENÍ	Vleže na zádech koleno přitažené k opačnému rameni.
DÁVKOVÁNÍ	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Přerušovat dlouhé sezení; na tvrdé židli polštář.

38. Gluteus medius

Musculus gluteus medius

KDE HLEDAT	2–5 cm pod hřebenem kosti kyčelní, v horní zevní části hýždě.
PŘENESENÁ BOLEST	dolní část kříže, kost křížová, strana kyčle, hýždě
PACIENT	Vleže na boku, ošetřovaná strana nahoře.
TECHNIKA	• Komprese palcem pod hřebenem kosti kyčelní, postupně zepředu dozadu.
PROTAŽENÍ	Vleže na boku horní noha visí za tělem přes okraj lehátka; nebo ve stoje se zkříženýma nohama úklon do strany.
DÁVKOVÁNÍ	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Vyhýbat se stání na jedné noze a křížení nohou; posilování abduktorů kyčle.

39. Gluteus minimus

Musculus gluteus minimus

KDE HLEDAT	Hluboko pod gluteus medius, mezi hřebenem kosti kyčelní a velkým trochanterem.
PŘENESENÁ BOLEST	zevní strana stehna, zevní strana bérce, zadní strana stehna, kotník
PACIENT	Vleže na boku, ošetřovaná strana nahoře, horní koleno podložené.
TECHNIKA	• Hluboká, pomalá komprese palcem nebo loktem nad velkým trochanterem a před ním.
PROTAŽENÍ	Vleže na zádech noha zkřížená na opačnou stranu.
DÁVKOVÁNÍ	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Přerušovat dlouhé řízení auta a sezení.

Opatrně: Šíření bolesti připomíná ischias: pokud je přítomna necitlivost, slabost nebo změna reflexů, lékařské vyšetření k vyloučení kořenové příčiny.

40. Piriformis

Musculus piriformis

KDE HLEDAT	Ve střední a zevní třetině spojnice mezi zevním okrajem kosti křížové a vrcholem velkého trochanteru.
PŘENESENÁ BOLEST	hýždě, kost křížová, zadní strana stehna, zadní část kyčelního kloubu
PACIENT	Vleže na břiše, nebo na boku s pokrčeným horním kolenem.
TECHNIKA	• Hluboká komprese palcem nebo loktem na spojnici kosti křížové a velkého trochanteru.
PROTAŽENÍ	Vleže na zádech kotník ošetřované nohy na druhém koleni, druhé stehno přitažené k hrudníku (protažení do čtyřky).
DÁVKOVÁNÍ	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Nesedět na peněžence; vyhýbat se křížení nohou.

Opatrně: V blízkosti probíhá nervus ischiadicus: při necitlivosti snižte tlak; při trvalé necitlivosti nohy lékař.

41. Iliopsoas

Musculus iliopsoas

KDE HLEDAT	Na přední straně stehna pod tříselným vazem (laterálně od a. femoralis) a v břiše na vnitřní straně lopaty kosti kyčelní.
PŘENESENÁ BOLEST	kříž vedle páteře, kost křížová, přední strana stehna
PACIENT	Vleže na zádech, kolena pokrčená, aby se břišní stěna uvolnila.
TECHNIKA	• Pomalý, plošný tlak bříšky prstů na vnitřní straně lopaty kosti kyčelní, od břicha, při výdechu. • Na stehně pod tříselným vazem, laterálně od tepny.
PROTAŽENÍ	Poloha ve výpadu: zadní koleno na zemi, pánev tlačená dopředu.
DÁVKOVÁNÍ	2–3 × 20–30 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Po dlouhém sezení protažení ve výpadu.

> **Opatrně:** V blízkosti probíhá tepna (pulzuje): nikdy na ni netlačte. Při břišních potížích a v těhotenství břišní část neošetřujte.

42. Tensor fasciae latae (TFL)

Musculus tensor fasciae latae

KDE HLEDAT	V přední zevní části kyčle, pod spina iliaca anterior superior.
PŘENESENÁ BOLEST	zevní strana stehna, zevní strana kolena
PACIENT	Vleže na zádech nebo na boku.
TECHNIKA	• Komprese palcem pod předním hrotem kosti kyčelní a laterálně od něj.
PROTAŽENÍ	Vleže na boku horní noha natažená, spuštěná dozadu a dolů.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Při sezení nemít stehna příliš ohnutá.

43. Adductor longus

Musculus adductor longus

KDE HLEDAT	Na vnitřní straně stehna, v horní třetině.
PŘENESENÁ BOLEST	tříslo, vnitřní strana stehna, vnitřní strana kolena
PACIENT	Vleže na zádech, koleno pokrčené a spuštěné do strany.
TECHNIKA	• Klešťový úchop na bříšku svalu. • Plošná komprese na vnitřní straně stehna.
PROTAŽENÍ	Vsedě chodidla k sobě (motýlek), kolena spuštěná dolů.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Zahřátí před prudkými bočními pohyby.

44. Adductor magnus

Musculus adductor magnus

KDE HLEDAT	Na vnitřně-zadní straně stehna, ve střední třetině, a v blízkosti sedacího hrbolu.
PŘENESENÁ BOLEST	tříslo, vnitřní strana stehna, hluboko v pánvi
PACIENT	Vleže na zádech, koleno pokrčené a spuštěné do strany, nebo vleže na boku.
TECHNIKA	• Plošná komprese na vnitřně-zadní straně stehna.
PROTAŽENÍ	Vsedě v roznožení předklon.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Postupná zátěž, zahřátí.

Opatrně: U potíží v malé pánvi nebo gynekologických potíží nejprve lékařské vyšetření.

45. Pectineus

Musculus pectineus

KDE HLEDAT	Na vnitřně-přední straně stehna, pod tříselným ohbím, mediálně od a. femoralis.
PŘENESENÁ BOLEST	hluboko v třísle, vnitřně-přední strana stehna
PACIENT	Vleže na zádech, noha mírně v abdukci a zevní rotaci.
TECHNIKA	• Pomalý, plošný tlak bříšky prstů pod tříselným ohbím, mediálně od tepny.
PROTAŽENÍ	Noha v abdukci a natažená, mírně dozadu.
DÁVKOVÁNÍ	2–3 × 20–30 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Při sezení nemít stehna stisknutá k sobě.

Opatrně: V blízkosti je tepna, žíla a tříselné mízní uzliny: jemně a nikdy na pulzující oblasti.

46. Sartorius

Musculus sartorius

KDE HLEDAT	Šikmo přes přední stranu stehna, od předního hrotu kosti kyčelní k vnitřní straně kolena, povrchově.
PŘENESENÁ BOLEST	přední strana stehna (pálivý, bodavý pocit), vnitřní strana kolena
PACIENT	Vleže na zádech.
TECHNIKA	• Klešťový úchop na tenkém svalovém pruhu, postupně shora dolů.
PROTAŽENÍ	Kyčel v extenzi, mírně ve vnitřní rotaci (poloha ve výpadu).
DÁVKOVÁNÍ	3 × 20–30 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Vyhýbat se dlouhému sezení v tureckém sedu.

ČÁST 6

Stehno, bérec a chodidlo

14 svalů, v pořadí atlasu.

47. Rectus femoris

Musculus rectus femoris

KDE HLEDAT	Na přední straně stehna, těsně pod kyčlí, v blízkosti spina iliaca anterior inferior.
PŘENESENÁ BOLEST	přední část kolena, kolem čéšky
PACIENT	Vleže na zádech.
TECHNIKA	• Plošná nebo klešťová komprese v horní přední části stehna.
PROTAŽENÍ	Vleže na břiše nebo ve stoje pata přitažená k hýždi, kyčel v extenzi.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Postupná zátěž při chůzi do schodů a dřepech.

48. Vastus medialis

Musculus vastus medialis

KDE HLEDAT	Na vnitřní přední straně stehna, 5–10 cm nad kolenem.
PŘENESENÁ BOLEST	vnitřní strana kolena, přední část kolena
PACIENT	Vleže na zádech, pod kolenem malý polštář.
TECHNIKA	• Plošná komprese palcem nad kolenem na vnitřní straně.
PROTAŽENÍ	Koleno plně pokrčené (pata k hýždi).
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Posilování: vsedě natažení kolena s výdrží.

49. Vastus lateralis

Musculus vastus lateralis

KDE HLEDAT	Na zevní straně stehna, v několika bodech mezi kyčlí a kolenem.
PŘENESENÁ BOLEST	zevní strana stehna, zevní strana kolena, za čéškou
PACIENT	Vleže na boku, ošetřovaná strana nahoře.
TECHNIKA	• Komprese loktem nebo palcem na zevní straně stehna, zdola nahoru.
PROTAŽENÍ	Koleno plně pokrčené, noha mírně ve vnitřní rotaci.
DÁVKOVÁNÍ	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Neležet na boku na bolestivé straně.

50. Biceps femoris

Musculus biceps femoris

KDE HLEDAT	Na zadní zevní straně stehna, ve střední a dolní třetině.
PŘENESENÁ BOLEST	podkolenní jamka, zadní strana stehna
PACIENT	Vleže na břiše, pod kotníkem polštář.
TECHNIKA	• Klešťový úchop nebo komprese palcem na zadní zevní straně stehna.
PROTAŽENÍ	Vleže na zádech zvedání natažené nohy, kotník přitažený.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Při dlouhém sezení nesmí hrana židle tlačit na stehno.

51. Semitendinosus / semimembranosus

Mm. semitendinosus et semimembranosus

KDE HLEDAT	Na zadní vnitřní straně stehna, ve střední a dolní třetině.
PŘENESENÁ BOLEST	dolní část hýždě, zadní strana stehna, vnitřní strana podkolenní jamky
PACIENT	Vleže na břiše.
TECHNIKA	• Klešťový úchop na zadní vnitřní straně stehna.
PROTAŽENÍ	Vleže na zádech zvedání natažené nohy, mírně do strany.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Zahřátí před během.

52. Gastrocnemius

Musculus gastrocnemius

KDE HLEDAT	V horní části lýtka, ve vnitřní a zevní hlavě, pod podkolenní jamkou.
PŘENESENÁ BOLEST	klenba nohy, lýtko, podkolenní jamka
PACIENT	Vleže na břiše, pod kotníkem polštář.
TECHNIKA	• Klešťový úchop nebo komprese palcem na obou hlavách.
PROTAŽENÍ	Ve stoje u zdi, zadní noha natažená, pata na zemi.
DÁVKOVÁNÍ	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Při nočních křečích večerní protažení; dostatek tekutin.

> **Opatrně:** Jednostranný otok lýtka, teplota, zarudnutí (podezření na trombózu): nemasírovat, okamžitě k lékaři.

53. Soleus

Musculus soleus

KDE HLEDAT	V dolní části lýtka, hluboko pod gastrocnemiem, nad Achillovou šlachou.
PŘENESENÁ BOLEST	pata, lýtko, kost křížová (vzácně)
PACIENT	Vleže na břiše, koleno pokrčené do 90°.
TECHNIKA	• Plošná komprese v dolní části lýtka z obou stran.
PROTAŽENÍ	Ve stoje u zdi, zadní koleno mírně pokrčené, pata na zemi.
DÁVKOVÁNÍ	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Vyhýbat se botám na vysokém podpatku.

Opatrně: Při jednostranném otoku nebo teplotě lýtka neošetřovat: k vyloučení trombózy k lékaři.

54. Tibialis anterior

Musculus tibialis anterior

KDE HLEDAT	Laterálně vedle holenní kosti, v horní třetině bérce.
PŘENESENÁ BOLEST	přední strana kotníku, palec nohy
PACIENT	Vleže na zádech.
TECHNIKA	• Komprese palcem na bříšku svalu vedle holenní kosti.
PROTAŽENÍ	Kotník a prsty v plantární flexi (vsedě nárt podvrácený pod sebe).
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s protažení.
DOMŮ	Postupná běžecká zátěž; méně běhat po tvrdém povrchu.

Opatrně: Při silné bolesti holeně, která se zhoršuje při zátěži (podezření na únavovou zlomeninu), lékařské vyšetření.

55. Peroneus (fibularis) longus

Musculus fibularis longus

KDE HLEDAT	Na zevní straně bérce, v horní třetině, 2–4 cm pod hlavičkou fibuly.
PŘENESENÁ BOLEST	zevní kotník, zevní strana nohy
PACIENT	Vleže na boku, ošetřovaná strana nahoře.
TECHNIKA	• Komprese palcem na zevní straně bérce.
PROTAŽENÍ	Noha vytočená dovnitř a v plantární flexi.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Stabilizační cvičení kotníku ve stoji na jedné noze.

Opatrně: Za hlavičkou fibuly probíhá nervus peroneus: tam netlačte.

56. Tibialis posterior

Musculus tibialis posterior

KDE HLEDAT	Hluboko pod lýtkem, za vnitřně-zadním okrajem holenní kosti.
PŘENESENÁ BOLEST	Achillova šlacha, pata, chodidlo
PACIENT	Vleže na břiše, koleno pokrčené.
TECHNIKA	• Hluboká, pomalá komprese za vnitřně-zadním okrajem holenní kosti.
PROTAŽENÍ	Noha vytočená zevně a v dorzální flexi.
DÁVKOVÁNÍ	2–3 × 30–60 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Vhodná podpora klenby; při ploché noze specialista.

57. Extensor digitorum longus

Musculus extensor digitorum longus

KDE HLEDAT	Na přední zevní straně bérce, laterálně vedle tibialis anterior, v horní třetině.
PŘENESENÁ BOLEST	hřbet nohy, prostřední prsty nohy
PACIENT	Vleže na zádech.
TECHNIKA	• Komprese palcem na přední zevní straně bérce.
PROTAŽENÍ	Prsty a kotník v plantární flexi.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Vyhýbat se těsné obuvi.

58. Flexor digitorum brevis

Musculus flexor digitorum brevis

KDE HLEDAT	Uprostřed chodidla, před patou.
PŘENESENÁ BOLEST	střed chodidla, kořeny prstů nohy
PACIENT	Vleže na břiše, noha přes konec lehátka.
TECHNIKA	• Komprese palcem uprostřed chodidla. • Pomalé tahy míčkem nebo kloubem prstu.
PROTAŽENÍ	Prsty nohy přitažené nahoru, kotník v dorzální flexi.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Vhodná obuv; masáž chodidla míčkem.

Opatrně: Při ostré bolesti paty při prvních ranních krocích (zánět plantární fascie) lékař nebo specialista.

59. Abductor hallucis

Musculus abductor hallucis

KDE HLEDAT	Na vnitřním okraji chodidla, mezi patou a kořenem palce.
PŘENESENÁ BOLEST	vnitřní strana paty, vnitřní okraj klenby
PACIENT	Vleže na boku, vnitřní strana ošetřované nohy nahoře.
TECHNIKA	• Komprese palcem na vnitřním okraji chodidla.
PROTAŽENÍ	Palec nohy tažený dovnitř (k ostatním prstům), kotník v dorzální flexi.
DÁVKOVÁNÍ	3 × 30–60 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Obuv se širší špičkou; posilování palce nohy.

60. Quadratus plantae

Musculus quadratus plantae

KDE HLEDAT	V zadní části chodidla, v hloubce, těsně před patní kostí.
PŘENESENÁ BOLEST	plantární plocha paty
PACIENT	Vleže na břiše, noha přes konec lehátka.
TECHNIKA	• Hluboká, pomalá komprese palcem před patou.
PROTAŽENÍ	Prsty a kotník v dorzální flexi.
DÁVKOVÁNÍ	2–3 × 30–60 s, 3 × 20 s protažení.
DOMŮ	Masáž chodidla míčkem, pohodlná obuv.

> **Opatrně:** Při otoku, necitlivosti nebo noční bolesti paty lékařské vyšetření.

Další krok

Dnes: přečtěte si obecné zásady. **Zítra:** u dalšího pacienta s bolestí krku nebo ramene postupujte podle protokolu pro trapezius a levator scapulae a zapište si, co jste zjistili.